

Poprawa ruchomości stawów skokowych

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel

Poprawa zgięcia grzbietowego, ruchomości łydki i kontroli stopy potrzebnej do chodu, przysiadu i schodów.

Uwaga kliniczna

Po świeżym skręceniu, złamaniu lub operacji zakres obciążania powinien wynikać z zaleceń prowadzącego lekarza/fizjoterapeuty.

1 JOGA 1

Pies z głową w dół - naprzemiennie pięty

Ustaw się w psie z głową w dół. Naprzemiennie uginaj jedno kolano i kieruj przeciwną piętę w stronę podłoża.

Dawka: 8-12/stronę

Wskazówka: Pięta nie musi dotykać podłogi.

2 JOGA 2

Krzesło z ciężarem na całej stopie

Z pozycji stojącej cofnij biodra i ugnij kolana, utrzymując pięty na podłożu. Kolana przesuwać się nad stopami w komfortowym zakresie.

Dawka: 15-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadać łuków stóp do środka.

3 POZIOM 1 - łatwy

Kolano do ściany

Stań przodem do ściany, stopa płasko. Prowadź kolano do ściany nad 2.-3. palcem bez odrywania pięty. Jeśli łatwo - odsuń stopę od ściany.

Dawka: 8-12/stronę x 2

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcie i powolne opuszczanie pięty

Stań na obu stopach przy ścianie. Unieś pięty wysoko, zatrzymaj 1 s i opuszczaj przez 3 s.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Ruch symetryczny, ciężar na podstawie palucha i małego palca.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Przysiad głęboki z podparciem

Trzymając się stabilnego oparcia, zejść do przysiadu tak głęboko, jak pozwalają biodra i kostki. Pięty pozostają na podłożu.

Dawka: 20-40 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj głębokości kosztem bólu kolan lub stóp.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.